



Чек-лист сложного клиента

7 СИТУАЦИЙ, КОГДА ПРИВЫЧНУЮ ТРЕНИРОВОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ СТОИТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Как понять, что клиенту недостаточно просто поменять упражнение, добавить нагрузку или ещё раз «укрепить слабую зону».



ЖАЛОБА ВЫГЛЯДИТ ПРИВЫЧНОЙ, НО ЗА НЕЙ **МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ**

Отметьте, если клиент говорит:

- ☐ «Не уходит живот, хотя я тренируюсь»
- ☐ «К вечеру живот вываливается»
- ☐ «Не чувствую, что корпус меня держит»
- ☐ «Не могу нормально удерживать планку / присед / тягу»
- ☐ «Болит поясница при упражнениях на пресс»
- ☐ «После родов тело стало нестабильным»
- ☐ «Есть диастаз или подозрение на него»

Что важно

Не делать автоматический вывод:

«Слабый пресс → надо больше пресса».

И одновременно не делать вывод:

«Значит, проблема точно в тазовом дне».



Правильный следующий шаг:

расширить оценку клиента и собрать дополнительную информацию.

СИМПТОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ УСИЛИВАЕТСЯ **ПРИ НАГРУЗКЕ**

Обратите внимание, если:

- ☐ при прыжках или беге появляется подтекание;
- ☐ после пресса или планки становится хуже;
- ☐ после приседаний или тяг появляются неприятные ощущения;
- ☐ возникает давление вниз;
- ☐ появляется тяжесть в тазу или внизу живота;
- ☐ усиливается боль в пояснице или тазу;
- ☐ симптомы проявляются не сразу, а после тренировки.

В презентациях отдельной ошибкой обозначены прыжки и бег без адаптации, пресс «на автомате», планки при нарушенном контроле корпуса и силовая работа без учёта симптомов.

Важно

Если привычное упражнение провоцирует или усиливает симптом, задача специалиста — не заставлять клиента «привыкнуть к нагрузке», а пересмотреть её.

Это может означать:

адаптировать упражнение → изменить тренировочную стратегию → провести дополнительную оценку → при необходимости направить к врачу.

КЛИЕНТ ВЫПОЛНЯЕТ УПРАЖНЕНИЕ, НО СИСТЕМА **НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С НАГРУЗКОЙ**

Смотрите не только на внешнюю технику движения.

Обратите внимание:

- ☐ задерживается ли дыхание;
- ☐ появляется ли натуживание;
- ☐ выталкивается ли живот;
- ☐ появляется ли давление вниз;
- ☐ сохраняется ли контроль корпуса;
- ☐ как работает живот;
- ☐ как клиент реагирует на увеличение нагрузки.

На втором дне интенсив строился вокруг идеи, что тазовое дно нельзя рассматривать отдельно: в работу включены **дыхание, диафрагма, внутрибрюшное давление, мышцы живота, тазобедренные суставы, поясница, корпус и физическая активность.**

Поэтому

Следующая прогрессия не всегда означает:

больше вес → больше повторений → сложнее упражнение.

Иногда сначала нужно понять, как клиент **управляет дыханием, давлением и корпусом.**

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ, НО ОН НЕСТАБИЛЬНЫЙ

Отметьте, если:

- ☐ после упражнений становится лучше, но боль возвращается;
- ☐ клиент регулярно тренирует пресс, но живот продолжает выпирать;
- ☐ приходится постоянно возвращаться к одной и той же жалобе;
- ☐ упражнения меняются, а устойчивого результата нет;
- ☐ после десятков тренировок вы всё ещё не понимаете, почему
- ☐ проблема сохраняется.

Эта ситуация прямо используется в материалах интенсива как пример, когда специалисту перестаёт хватать отдельных упражнений: «не уходит живот», «возвращается боль в пояснице», «нет результата после десятков тренировок».

В этот момент вопрос должен измениться

He:

«Какое ещё упражнение попробовать?»

A:

«Что я ещё не оценил и почему привычная стратегия не даёт устойчивого результата?»

В АНАМНЕЗЕ ЕСТЬ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ **БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ**

Особенно внимательно собирайте информацию, если были:

- ☐ беременность и роды;
- ☐ сложные или травматичные роды;
- ☐ кесарево сечение;
- ☐ многоплодная беременность;
- ☐ крупный плод;
- ☐ эпизиотомия или разрывы;
- ☐ операции на органах малого таза;
- ☐ мочеполовые операции;
- ☐ хронические запоры и регулярное натуживание;
- ☐ хронический кашель;
- ☐ интенсивные прыжковые или силовые нагрузки;
- ☐ менопауза и возрастные изменения.

Эти ситуации отдельно перечислены в первом дне интенсива как повод **не делать вывод только по внешнему виду клиента, а задавать дополнительные вопросы.**

Важно

Сам факт родов, операции или возраста **не означает запрет на тренировку.**

Он означает:

«Мне нужно больше информации, прежде чем выбирать стратегию нагрузки».

ХОЧЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Например:

«Слабое тазовое дно → Кегель».

«Выпирает живот → больше пресса».

«Слабый корпус → больше планок».

Но одна из ключевых идей второго и третьего дней:

одинаковый симптом не означает одинаковое состояние.

В презентации отдельно разбирается, что клиенту может требоваться не только активация, но и **расслабление, координация, работа с дыханием, давлением и адаптация нагрузки.**

Кроме того, в системе курса различаются, например, гипотонус и гипертонус: при избыточном напряжении автоматическое добавление упражнений на сжатие может быть неподходящей стратегией.



Поэтому главное правило:

**Сначала понять состояние —
потом выбирать упражнение.**

Не наоборот.

ВЫ САМИ **НЕ ПОНИМАЕТЕ**, МОЖНО ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ

Это тоже важный профессиональный сигнал.

Отметьте, если возникают мысли:

- ☐ «Я не понимаю, безопасно ли продолжать эту нагрузку»
- ☐ «Не знаю, могу ли я вести этого клиента самостоятельно»
- ☐ «Не понимаю, нужно ли отправлять его к врачу»
- ☐ «Не знаю, какие вопросы ещё нужно задать»
- ☐ «Не понимаю, что оценивать дальше»
- ☐ «Боюсь навредить»
- ☐ «На всякий случай хочется вообще всё запретить»

На интенсиве отдельно подчеркивается, что типичная проблема специалистов — две крайности: **либо брать всех клиентов подряд, либо бояться работать даже с теми, с кем можно безопасно работать через движение.**

Хороший специалист — не тот, кто берёт всех.

Хороший специалист понимает **границы своей компетенции** и знает, когда нужен другой специалист.

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

Нужно ли пересмотреть привычную стратегию?

Поставьте ✓, если ответ «да».

Вопрос	Да
Жалоба возвращается, несмотря на регулярную работу?	☐
Симптом появляется или усиливается во время/после нагрузки?	☐
Клиент плохо управляет дыханием, давлением или корпусом?	☐
Есть значимый послеродовой, операционный или другой анамнез?	☐
За одной локальной жалобой обнаруживается несколько симптомов?	☐
Стандартное «укрепить ещё больше» не даёт результата?	☐
Вы не можете уверенно решить, можно ли продолжать работу самостоятельно?	☐

Если отметили хотя бы один пункт

Это не диагноз и не доказательство дисфункции тазового дна.

Это сигнал:

«Не продолжаю тренировочную прогрессию автоматически. Сначала уточняю ситуацию».

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Здесь я бы уже не придумывала новую упрощённую схему, а прямо использовала алгоритм, который повторялся на первом и втором днях интенсива.

Шаг 1. Общее анкетирование

Собрать

- ✓ жалобы;
- ✓ анамнез;
- ✓ информацию о текущем состоянии.

Если признаков возможной дисфункции нет, клиент может приниматься в работу по стандартной схеме.

Шаг 2. Специализированный опросник по тазовому дну

Если появляются возможные сигналы:

- ✓ подтекание;
- ✓ выпирающий живот;
- ✓ тяжесть внизу живота;
- ✓ послеродовые изменения;
- ✓ боли в пояснице или тазу;
- ✓ другие характерные жалобы.

подключается
дополнительный опросник.

Шаг 3. Диагностическая встреча

На встрече проводится:

- ✓ анализ жалоб;
- ✓ визуальная оценка;
- ✓ оценка осанки;
- ✓ оценка дыхания;
- ✓ оценка движения, работы живота и реакции на нагрузку;
- ✓ определение дальнейшей тактики.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Шаг 4. Профильный врач — при необходимости

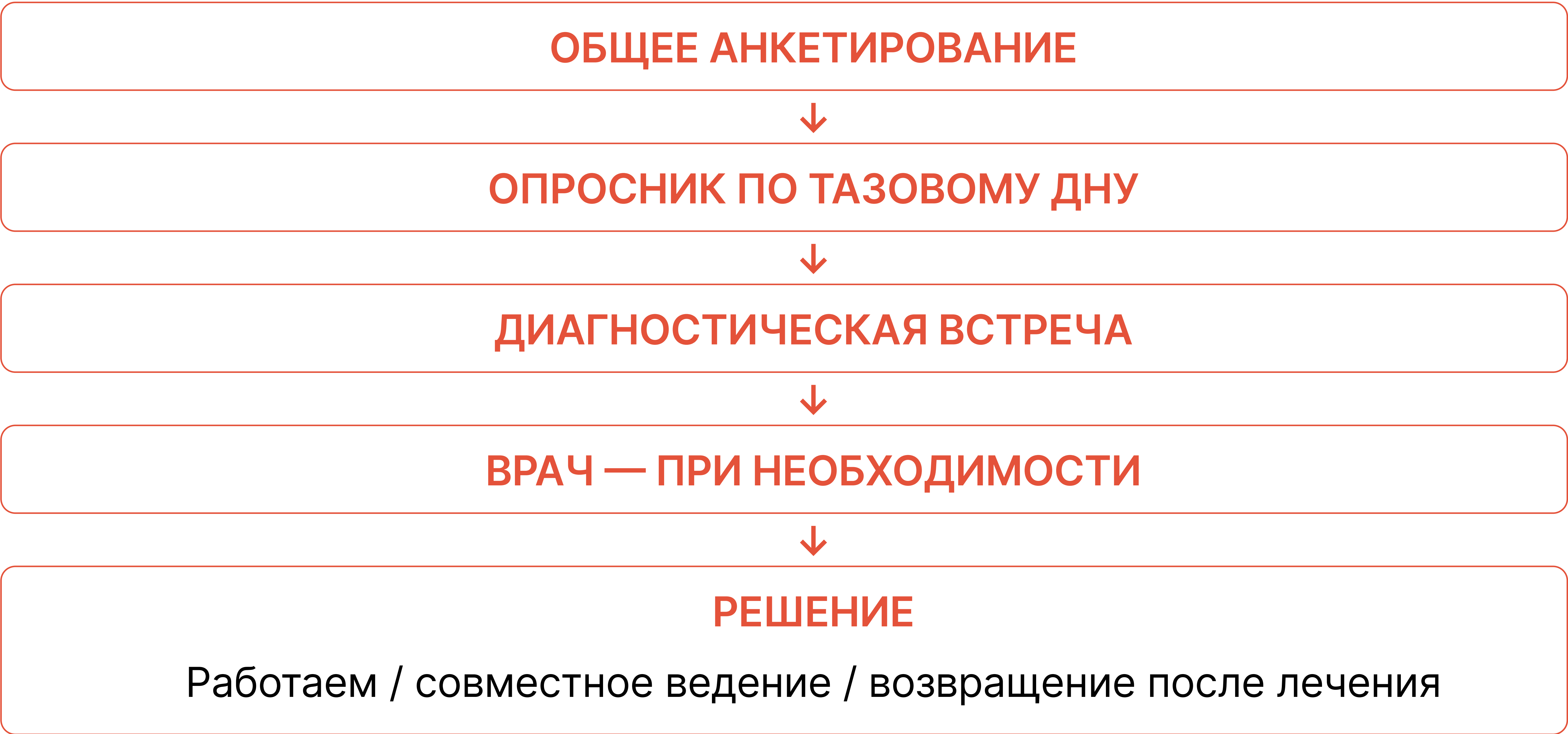
При выраженных нарушениях, признаках опущения или другихстораживающих симптомах клиент направляется к врачу.

Специалист по движению **не ставит диагноз и не заменяет врача**. Его задача — увидеть возможные нарушения, безопасно работать с нагрузкой и при необходимости работать в команде с медицинским специалистом.

Шаг 5. Принятие решения

По итогам:

- Вариант 1
- Берём клиента в работу.
-
- Вариант 2
- Работаем параллельно с врачом.
-
- Вариант 3
- Сначала медицинское лечение / операция, затем возвращение к восстановлению и движению.



ЕСЛИ КЛИЕНТ ОСТАЁТСЯ В РАБОТЕ

Вот здесь важно добавить то, чего не было в моей предыдущей версии.

После диагностики задача специалиста не заканчивается выбором первого упражнения.

Работа строится как последовательность:

1. Понять задачу клиента

2. Составить индивидуальный тренировочный план

3. Подбирать упражнения не по принципу «что полезно вообще», а понимать:

- ✓ зачем нужно конкретное упражнение;
 - ✓ на какую структуру оно воздействует;
 - ✓ в какой последовательности его использовать.
-

4. Оценивать реакцию клиента

5. При необходимости менять программу

6. Контролировать динамику результата

В презентациях результат предлагается отслеживать по трём критериям:

1. Ощущения самой клиентки
 2. Визуальные изменения тела
 3. Медицинская динамика — если женщина наблюдается у врача
-



Формула работы:

**Понимаю тело → вижу причину →
провожу диагностику → подбираю
решение → контролирую результат**

Эта формула прямо используется в материалах интенсива как итог системного подхода.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ СО СЛОЖНЫМ КЛИЕНТОМ

- ✗ Не давать пресс «на автомате»
- ✗ Не прогрессировать прыжки и бег, игнорируя симптомы
- ✗ Не оставлять планку только потому, что клиент технически способен её выполнить
- ✗ Не увеличивать силовую нагрузку, не учитывая реакцию тела
- ✗ Не использовать Кегель как универсальное решение
- ✗ Не рассматривать тазовое дно отдельно от дыхания, давления, живота, таза и движения
- ✗ Не ставить медицинский диагноз самостоятельно

Эти ошибки и необходимость переходить от локального симптома к системе последовательно разбираются на первом и втором днях интенсива.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

СЛОЖНЫЙ КЛИЕНТ — НЕ ВСЕГДА КЛИЕНТ СО СЛОЖНЫМ ДИАГНОЗОМ.

Иногда это клиент, у которого:

- ✓ привычное упражнение перестало работать;
- ✓ симптом возвращается;
- ✓ нагрузка провоцирует ухудшение;
- ✓ за одной жалобой обнаруживается несколько взаимосвязанных сигналов;
- ✓ специалисту не хватает информации для уверенного решения.

И здесь профессиональная работа начинается не с поиска ещё одного упражнения.

Она начинается с правильной последовательности:

спросить → оценить → определить границы →
принять решение → подобрать стратегию →
контролировать результат.



**Если вы не понимаете, почему
привычная стратегия не работает, —
это не повод делать больше. Это повод
сначала разобраться глубже.**